

13 - 02- Les Troubles Bipolaires - Pr. Manoudi

Pour la première fois, les états dépressifs. Aujourd'hui, on va voir les troubles bipolaires. C'est toujours en pluriel parce qu'on va voir il y a plusieurs troubles bipolaires et il y a trois qui sont reconnus dans la classification du manuel statistique et diagnostique des maladies.

Les autres, c'est des auteurs, des scientifiques qui ont essayé de décortiquer vraiment les symptômes pour sortir le trouble bipolaire type 4, 4,5, 5, 5,5, type 6, type 7, vraiment en fonction des symptômes. Par rapport au type 1, 2, 3, le traitement est différent. C'est pour ça qu'il faut connaître les trois types.

Alors, les troubles bipolaires, c'est l'opposé, carrément l'opposé de ce que vous avez vu dans les états dépressifs. Ce qu'il faut connaître à la fin de ce cours, d'abord définir les troubles bipolaires, décrire un accès maniaque. Il y a une phase de début et une phase d'état.

Les risques liés à l'accès maniaque, c'est pour ça qu'il faut le prendre en charge précocement. Les différentes formes de troubles bipolaires les plus répandues auxquelles on a des traitements. Définir l'hypomanie, c'est très important de connaître les symptômes de l'hypomanie.

On a dit la dernière fois qu'il va carrément changer le diagnostic quand vous êtes devant un état dépressif et le patient a des antécédents d'hypomanie, ça change complètement le traitement. L'évolution d'un trouble bipolaire avec et sans traitement, pour encourager les gens à prendre leur traitement. Les facteurs de gravité, on va avoir des facteurs de gravité liés au trouble lui-même et des facteurs de gravité liés à la prise en charge.

Bien sûr, le diagnostic différentiel, on élimine toujours au début tout ce qui est organique avant de penser à tout ce qui est organique psychiatrique. Et bien sûr, traiter, donc connaître les grandes lignes du traitement. On va voir, c'est un peu compliqué, mais vous devez quand même connaître les grandes lignes du traitement.

L'essentiel aussi, c'est connaître les principaux, les principes de la psychoéducation comme ce que vous allez faire pour un diabétique, un épileptique. Vous êtes censé faire la psychoéducation pour un patient bipolaire, pour un patient schizophrène. Pour les deux pathologies, on ne va pas parler de psychoéducation pour le trouble anxieux parce que les deux pathologies, trouble bipolaire et la schizophrénie, sont des pathologies chroniques handicapantes qui peuvent handicaper le sujet sur le plan professionnel ou social.

Alors la définition, c'est une récurrence d'épisodes de manie, j'insiste, ou d'hypomanie avec ou sans épisodes dépressifs. On va voir par la suite, donc le sujet peut faire des épisodes maniaques et à un moment, il va faire des épisodes dépressifs. Il peut par exemple faire des épisodes hypomaniaques et à un moment, il va faire des épisodes dépressifs.

Donc il peut ne faire que des épisodes maniaques ou que des épisodes hypomaniaques et

malgré ça, on parle de bipolaire. Même s'il ne fait que des épisodes maniaques à répétition et il vient chez vous alors qu'il vient de faire par exemple 5 épisodes maniaques, ça fait 5 ans qu'il est suivi, c'est un trouble bipolaire. Pourquoi ? Parce que quand on dit bipolaire, ça sous-entend deux pôles.

Mais même quand il ne fait que des accès maniaques, on parle de bipolaire parce qu'on dit qu'il y a sûrement un épisode dépressif qui est passé inaperçu. Alors le risque de tentative de suicide est très important. Le suicide, on ne le trouve pas uniquement au niveau des phases dépressives mais aussi au niveau des phases maniaques.

Un patient maniaque peut avoir un risque suicidaire. Comment ? Est-ce que vous avez une idée ? Comment un patient maniaque qui a un accès maniaque peut faire une tentative de suicide ? C'est-à-dire ? Oui, qu'est-ce qu'il va se dire quand il conduit un grand suicide à un patient qui a un accès maniaque ? Il va conduire par exemple à 200 km à l'heure, qu'est-ce qu'il va se dire ? Je suis immortel, rien ne va m'arriver. D'accord ? Parce qu'il est mégalomane.

Parce que dans l'accès maniaque, il est dans la joie, l'euphorie, la mégalomanie. D'accord ? Ou bien il peut sauter du septième étage, il va se dire rien ne va m'arriver. Il peut même emporter avec lui ses enfants par exemple.

Il va se dire rien ne va m'arriver, on est immortel. D'accord ? Ou bien rien ne va m'arriver et mes enfants je vais les sauver. Je vais pouvoir voler avec eux, j'ai un pouvoir.

C'est la mégalomanie, il est délirant. D'accord ? C'est dans ce cadre. C'est pas dans un cadre dépressif mais dans un cadre maniaque.

Et il peut se suicider quand il est en accès dépressif. Donc il est bipolaire, il peut se suicider soit quand il est en accès maniaque, soit quand il est en accès dépressif. Donc le risque, il est là.

Le traitement préventif, là, c'est une maladie chronique. C'est une maladie qui peut handicaper le sujet, on va voir avec les symptômes. Mais il y a un traitement préventif qui peut prévenir les accès.

Ou bien au moins diminuer l'intensité des accès, diminuer la sévérité, diminuer la fréquence. Et un sujet qui suit bien son traitement, un patient qui est trop bipolaire, il peut fonctionner normalement. Il peut se marier, avoir des enfants, faire des études, avoir des diplômes.

Autour de vous, vous connaissez, il y a des médecins bipolaires qui fonctionnent, qui travaillent. Il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des ingénieurs bipolaires qui travaillent. Par contre, un schizophrène médecin peut ne pas bien fonctionner.

Alors qu'un bipolaire, il peut travailler normalement, s'il suit bien son traitement et si sa pathologie n'est pas sévère. C'est compliqué, on va le voir par la suite. Des fois, même avec le traitement, c'est compliqué de stabiliser un patient, mais ces cas sont rares.

Donc la règle, c'est la stabilisation sous traitement préventif. Un syndrome complexe, on va voir tous les symptômes qu'il y a dans cette pathologie. La physiopathe, elle est inconnue, on a des hypothèses.

Elle touche sur l'échelle mondiale 1% de la population et elle représente 50% de la clientèle des hôpitaux psychiatriques. Vous allez voir pour les gens qui sont passés au service ou bien qui sont actuellement au service, la majorité de nos patients qu'on hospitalise, on ne hospitalise que les bipolaires. On accède les schizophrènes en général.

Et sinon, les dépressifs suicidaires. C'est les cas qu'on hospitalise dans le service, c'est les urgences psychiatriques. Et la moitié, c'est des bipolaires, la moitié, c'est des schizophrènes.

Alors un peu d'histoire, c'était Kripplin, vous voyez la date. Elle a parlé de psychose maniaco-dépressive. On peut toujours parler de psychose maniaco-dépressive, juste pour faciliter la nomination par rapport aux différents scientifiques.

Actuellement, on parle de troubles bipolaires. Déjà en 1899, Kripplin, il a différencié les patients. Il a dit qu'il voyait des patients, des fois, ils arrivaient en phase dépressive, des fois, ils arrivaient en phase maniaque.

Et elle a appelé ça, elle a vu que c'était une maladie chronique handicapante et elle a appelé ça une psychose maniaco-dépressive. Parce que déjà à l'époque, on a partagé les psychoses, qui sont les maladies chroniques handicapantes, des névroses, qui sont les maladies qu'on peut guérir. Alors après, il y a eu la différence entre troubles bipolaires et troubles unipolaires.

C'est quoi un trouble unipolaire ? La dépression qui se répète, d'accord ? Quand il y a une récurrence d'un épisode dépressif, sans épisode maniaque, sans épisode hypomaniaque, on parle d'un trouble unipolaire. C'est soit dépressif, soit maniaque, soit dépressif et maniaque qui se répète. Après, en 1960, ça aussi c'est une très grande invention, c'est la découverte du rôle du lithium dans la prévention, comme traitement préventif des accès maniaques, donc surtout les accès maniaques.

Donc là, le lithium c'est un traitement qu'on utilisait pour la goutte, et on a constaté que chez ces patients qui avaient aussi un trouble bipolaire, il y avait une amélioration de leur symptomatologie. La plupart des médicaments sont découverts comme ça. Il y a des patients qui ont des problèmes organiques, qui commencent à prendre des médicaments, et on a constaté que soit ça règle l'humeur, soit ça règle les hallucinations, soit comme ici ça calme les accès maniaques, et de là on a découvert leur intérêt dans la pathologie psychiatrique.

Après, il y a les DSM qui vont parler de troubles bipolaires type 1, type 2, chaque fois en fonction des évolutions des DSM. Là, vous voyez le DSM 1, 2, on parlait de maladies maniaco-dépressives. Chaque fois, il y a en parallèle la classification internationale des maladies

françaises.

Le DSM, c'est la classification des troubles psychiatriques américaines. Et nous, quand on fait des recherches, on les fait en fonction du DSM. C'est le manuel diagnostique et statistique des maladies.

Alors ici, en 1980, il y a eu une séparation entre unipolaire, bipolaire et personnalité chimique. On va voir les problèmes cyclotimiques. Après, donc là, c'est pour définir l'unipolaire.

On a gardé les mêmes nominations. L'unipolaire, c'est la répétition d'épisodes dépressifs majeurs qui se répètent, récurrents. Alors le bipolaire, il y a le bipolaire type 1 et le bipolaire type 2, les deux les plus reconnus par la classification.

Dans le type 1, soit récurrence d'épisodes dépressifs majeurs et de manie, soit récurrence d'épisodes dépressifs mineurs et de manie, soit récurrence uniquement de manie. La récurrence d'épomanie, non, on ne parle pas de bipolaire. Alors le bipolaire type 2, c'est la récurrence d'épisodes dépressifs majeurs avec épomanie.

Si c'était une manie, on va être dans le bipolaire 1. Des fois, le malade, vous le suivez pour trop de bipolaire type 2, pendant des années, il vient pour vous, la première fois, on peut dire pour un accès maniaque, il ne va pas venir pour l'accès épomaniac. Pourquoi ? Oui, si vous voulez, c'est un accès que tout le monde veut avoir. C'est un petit peu comme les accès maniaques, mais il n'y a que du positif.

On va voir les symptômes. Donc pour lui, c'est la normale. Ça peut être un petit peu remarqué par l'entourage, mais c'est une personne qui est connue comme ça.

Une personne qui est joviale tout le temps, excitée tout le temps, tout le temps, il est en train de faire rigoler les autres, de donner des blagues et qui est active, qui dort peu, dont le rendement est très efficace, qui dépense beaucoup d'argent, mais quand même, il ne va pas jusqu'aux ruines économiques, mais c'est quelqu'un qui est actif. Donc, c'est des gens politiques, c'est des artistes. Là, vous les connaissez.

Donc là, il ne va pas consulter pour l'hypomanie. Il peut venir consulter chez vous pendant longtemps pour des dépressions. Si vous ne posez pas la question, si vous n'insistez pas, il ne va pas vous parler de son hypomanie parce que pour lui, c'est la normale.

Et si vous le mettez sur ce dépresseur seul, comme je vous ai dit la dernière fois, il peut faire un virage maniaque et il va passer dans le trouble bipolaire type 1 ou bien le type 3 si vous voulez. C'est parce qu'il ne va représenter que des accès maniaques. Donc là, il faut le mettre obligatoirement sous antidépresseur et sous tumor régulateur.

Si vous êtes obligé de le mettre sous antidépresseur. Des fois, on peut traiter la dépression par des tumor régulateurs ou bien par un neuroleptique. On va voir dans les guidelines ce qu'il y a

comme nouveauté.

Alors là, c'est de façon schématique pour bien comprendre. Donc là, j'ai mis obligatoire, il faut avoir des accès maniaques, obligatoire. Après, plus ou moins, plus ou moins.

Ça, ce n'est pas obligatoire. Là, le type 2, obligatoirement des accès hypomaniaques et obligatoirement des épisodes dépressifs majeurs. Les deux sont obligatoires.

Ce ne sont pas des épisodes dépressifs mineurs et ce ne sont pas des manies. Sinon, on va être dans le bipolaire type 1. Alors ça, c'est vraiment, c'est rare qu'on est dans le timide. Ça, c'est le trait horizontal.

C'est rare. Physiologiquement, les gens effluent. Vous-même, il y a une fluctuation de votre humeur.

Donc, vous faites comme ça. Donc, des hauts et des bas, un petit peu des hauts et des bas. Vous restez comme ça.

Vous pouvez rester un petit peu sur la ligne, mais un petit peu comme ça, comme ça, comme ça. Alors, les gens qui font des accès maniaques, donc, ils peuvent rester comme ça. Après, normal.

Après, ils descendent tout à fait au fond. Après, il peut y avoir des accès extrêmes, sévérité extrême. Et bien sûr, la fréquence dépend de chacun.

Il y en a qui vont faire un accès par an. Il y en a qui vont faire deux accès par an, trois, quatre, plus que quatre. Si c'est plus que quatre, c'est un cycle rapide.

Et il y en a qui vont faire un accès tous les deux ans. Il y en a qui vont faire tous les quatre ans, tous les cinq ans, tous les dix ans. Ça, c'est avec ou sans traitement.

Alors, la prévalence. Donc, on a beaucoup plus de troubles bipolaires chez les femmes, type 2, chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus de troubles bipolaires.

On a beaucoup plus de dépression chez les femmes que chez les hommes. Et dans le type 2, on a dit qu'il y a des dépressions majeures. D'accord ? Je ne sais pas comment ils vont voir.

Vous ne pouvez pas savoir comment les autres voient le tableau. Il est partagé. D'accord.

Mais en général, les troubles bipolaires, toutes catégories confondues, sont à sexe égal entre les hommes et les femmes. Alors, le début, l'âge de début moyen, il est de 21 ans. En général, comme les schizophrénies, ça va de 15 à 19 ans.

Donc, la schizophrénie, les schizophrénies, les troubles bipolaires, c'est vraiment début de l'adolescence, que les troubles peuvent commencer. C'est rare que les familles détectent les

débuts du trouble, ce qu'on appelle les prodromes. Avant même le déclenchement des vrais symptômes positifs, il y a des prodromes qui peuvent orienter.

Ce n'est pas que par la suite, à l'âge un petit peu tardif, 19 ans, 20 ans, 25 ans, que les familles commencent à se rappeler. C'est vrai, à 15 ans, elle a commencé déjà à s'isoler. C'est vrai, depuis son adolescence, elle n'a plus d'amis. C'est vrai, elle commençait à faire des comportements bizarres, comme par exemple, sélectionner la nourriture, ne manger par exemple que les aliments qui sont ronds, que les petits pois, que le maïs, ou bien ne manger que les aliments qui sont rouges, des comportements un petit peu bizarres.

Les problèmes de sommeil, par exemple, se lever la nuit et faire des comportements bizarres, ça c'est des prodromes. Alors, le délai avant le premier traitement, 5 à 10 ans. Vous voyez, 10 ans, ça entraîne un mauvais pronostic, parce que plus le traitement est précoce, plus le pronostic est bon.

Que ce soit pour les troubles épaulaires, que ce soit pour les schizophrénies, à chaque accès, le cerveau est endommagé. C'est comme le cas, par exemple, des crises d'épilepsie. Là, on fait attention, on insiste sur les mamans de faire attention, sur la famille de faire attention, l'enfant ou bien le patient ne doit pas faire beaucoup de crises, parce que les crises vont engendrer d'autres crises.

Chaque crise endommage le cerveau, c'est le même cas pour les troubles épaulaires et pour les accès, pour les troubles schizophréniques. Donc, chaque accès va accélérer l'apparition d'autres accès. D'ailleurs, ce parallélisme entre les troubles épaulaires et l'épilepsie, dans ce qu'on appelle le phénomène de Kiedling, c'est-à-dire que chaque accès va accélérer, va favoriser l'apparition du prochain accès, qu'on a pensé utiliser les tumeurs régulateurs anti-épileptiques dans le traitement préventif des troubles épaulaires.

Dans les deux, dans les crises d'épilepsie comme dans les troubles épaulaires, chaque accès favorise et accélère l'apparition de l'accès suivant. Et on a pensé que, puisqu'ils ont ce même mécanisme d'action, on va donner des traitements anti-épileptiques, comme la Depakine et le Tegretol, et les utiliser comme traitement préventif du trouble bipolaire. Vous voyez comment on a découvert ces médicaments.

Après le pic, bien sûr, entre 15 et 30 ans, comme les schizophrénies, après 60 ans, c'est vrai, comme les troubles psychotiques, même les schizophrénies, après 60 ans, c'est rare. Si on a un trouble psychiatrique après 60 ans, surtout psychotique, il faut chercher toujours s'il n'y a pas un problème organique. Autre, s'il n'y a pas une tumeur cérébrale ou bien une maladie de système ou bien un autre problème organique, neurologique ou bien un problème infectiologique.

Ça, c'est important parce que c'est des choses que vous allez rencontrer, vous, dans vos cabinets. 7 patients sur 10 sont initialement mal diagnostiqués, c'est-à-dire, initialement, ils

peuvent être diagnostiqués, soit surtout dépressifs, alors que ça sous-entend qu'il y a d'autres troubles qu'on n'a pas bien cherchés. 30 % consultent pour des symptômes dépressifs pour avoir par la suite un trouble bipolaire.

Un patient sur trois est à la demande de soins pendant 10 ans avant d'être correctement diagnostiqué. C'est ce qu'on a dit, le retard de diagnostic peut aller jusqu'à 10 ans. Alors, les comorbidités aussi sont importantes.

Chaque fois que vous êtes devant un trouble psychiatrique, il faut toujours chercher les autres troubles. Le trouble psychiatrique, le premier que vous voyez, ça ne peut être que la partie évidente, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de l'iceberg, mais il y a d'autres troubles qui sont sous-jacents. Les plus fréquents, c'est le trouble de personnalité qu'on peut trouver avec n'importe quel trouble, surtout avec les troubles dépressifs, avec les troubles anxieux.

Mais avec les autres troubles, avec les troubles anxieux, il peut y avoir l'association entre eux, il peut y avoir l'association avec les troubles dépressifs et avec le trouble bipolaire. Là, il y a beaucoup d'associations avec l'abus de substances, surtout la prise d'alcool. Les patients qui ont des troubles bipolaires, ils aiment bien rester au niveau de la phase de l'accès maniaque, parce que pendant cet accès, ils sont joyeux, ils ont de l'euphorie, ils sont contents, hyper contents.

Alors, quand ils sont dans la phase dépressive, ils sont tristes, ils n'ont envie de rien faire, pas de projet, ils ne sont pas actifs. Donc, ils ont un petit peu la nostalgie de garder la phase maniaque. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller vers les toxiques.

Les toxiques, surtout l'alcool, pour récupérer cette phase de l'accès maniaque. Et bien sûr, quand ils prennent les toxiques, ça aggrave l'accès maniaque. Donc, ça aggrave et c'est de mauvais pronostics.

Même aussi, le risque suicidaire, il est plus grave, s'il y a association avec des abus de substances. Il y a aussi une association, selon les études, avec les troubles de panique, qui est beaucoup plus fréquente que dans la population générale, sans troubles bipolaires. Là, c'est la fameuse étude dont je vous ai parlé la dernière fois.

On a donné le chiffre pour le trouble dépressif, qui est de 26,5. Ici, pour l'épisode maniaque, regardez, 3,2% dans la population générale. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, voilà tous les troubles que l'étude a étudiés.

Les épisodes dépressifs, le dysthymie, les troubles anxieux, tous les troubles anxieux, l'état maniaque, et puis les abus de substances. Les abus de substances, on n'a pas vraiment précisé. Ça peut être le tabac.

C'est pour ça que les chiffres sont très élevés. Alors là, maintenant, on va voir les symptômes d'un accès maniaque. J'insiste sur le fait que c'est la récurrence d'épisodes maniaques avec ou

sans, donc pas obligatoirement de trouver un épisode dépressif.

Le début, en général, est brutal. C'est très brutal, le début de l'accès maniaque, ou rapidement progressif. Par rapport à quelle pathologie? Où est-ce qu'on voit un début progressif pour la pathologie? Une pathologie psychotique.

Vous avez fait l'esquizophrénie? Non, pas encore. Par rapport à l'esquizophrénie, le début est très progressif. Il peut même passer inaperçu, surtout s'il commence par des signes négatifs, où on a un isolement.

Le patient isolé, on ne va pas chercher... C'est rare qu'on cherche un adolescent qui est isolé, tranquille, ne dérange pas la famille. C'est rare qu'on cherche pourquoi vous êtes isolé, pourquoi vous ne causez pas de problèmes comme les autres adolescents. Ici, le début est brutal, comme un accès psychotique aigu.

Ça commence surtout par l'insomnie, et ça c'est très important comme symptôme à repérer, c'est ce qu'on appelle le signal d'alarme. Même les rechutes, des fois elles commencent par les mêmes symptômes, et le premier symptôme qui apparaît, c'est l'insomnie. Cette insomnie, elle est caractéristique.

Ce n'est pas un sommeil de 6 heures ou de 7 heures, c'est quelqu'un qui a l'habitude de dormir 8 heures, c'est 2 heures de sommeil, 3 heures de sommeil, et le sujet est hyperactif la journée. Vous, quand vous faites des gardes la nuit, vous faites des gardes, ou bien quand vous ne dormez pas la nuit, vous récupérez le lendemain. Le lendemain, vous êtes à légumes, d'accord ? Vous dormez l'après-midi, ou bien vous dormez après deux jours.

Et c'est peu que le lendemain, ça ne vous arrive pas de dormir, mais après deux jours, vous dormez pour récupérer, parce que physiologiquement, vous en avez besoin. Mais ici, l'insomnie, le lendemain, elle est hyperactive, et l'insomnie, elle peut durer 2, 3, 4 jours. Et il y a aussi des insomnies totales, des gens qui vont faire 2, 3 nuits blanches, ils sont actifs.

Imaginez un étudiant en médecine qui ne dort pas 2, 3, 4 jours et fait des gardes, et c'est des gens qui vont être actifs, qui vont demander à faire les gardes pour eux et pour les autres. Non, je me sens bien. Et des fois, personne ne pose la question.

Un sentiment de bien-être, et ça, on leur pose la question. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez vraiment joyeux, heureux ? Ils vont vous dire, oui, je suis joyeux, je suis heureux. Mais ce n'est pas être joyeux, heureux à la limite de la normale.

On insiste. Est-ce que ça dépasse la normale ? Est-ce que ce n'est pas comme d'habitude ? Est-ce que c'est remarqué par l'entourage ? Et ça, les patients, ils le ressentent. Ils le verbalisent, ils vont dire oui.

Alors, modification du caractère avec son activité, hyperactif, joyeux, un bien-être extrême, il va

faire des projets. Les projets, en général, et dans la majorité des cas, s'il a les moyens, il peut les réaliser. Mais des fois, c'est des projets qui sont irréalistes, qui n'est pas capable de réaliser.

Il va dire, par exemple, je vais construire une maison pour les enfants orphelins, je vais construire une mosquée, je vais construire un hôpital, je vais faire ça, je vais donner de l'argent aux pauvres. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais acheter beaucoup de choses. Des fois, s'il a les moyens, il peut les faire.

Et il va tomber dans les dépenses exagérées, quitte carrément à délapider tout son capital économique, perdre tout son argent. Ils vont même des fois donner des chèques sans provision. Il va y avoir des poursuites judiciaires, des conséquences judiciaires.

Il y en a qui vont faire la prison parce qu'ils ont donné des chèques sans provision. Bien sûr, l'hyperactivité et la désinhibition. Dans cette hyperactivité, il y a aussi une hyper familiarité avec les autres et il peut y avoir une désinhibition.

C'est quelqu'un qui va aborder les femmes de façon facile, même avec des mots un petit peu vulgaires, avec des mots un petit peu obscènes, qui peut même se dénuder dans la rue, il peut rester torse nu, il peut être nu carrément et on les reçoit comme ça des fois en consultation. Il y a aussi des comportements agressifs. Il est le meilleur, il est le plus fort, il est le plus riche.

Rien ne va lui arriver. Il peut être agressif envers les autres. Dans ces cas, quand vous êtes devant ces quelques symptômes, il faut poser des questions pour chercher les antécédents familiaux pour vous orienter.

Des fois, il n'y a que des petits symptômes, mais quand vous assistez à chercher d'autres symptômes, ça peut vous orienter pour le diagnostic. Si, par exemple, vous recevez un patient, des fois, même si on insiste sur l'insomnie, sur l'hyperactivité, sur les projets, oui, mais c'est normal, oui, mais j'arrive quand même. On est vraiment dans l'embarras, on ne peut pas savoir si c'est vraiment un accès ou pas.

Là, on pose la question par rapport à la famille. S'il y a une charge familiale de troubles chimiques, là, on est orienté. On va se dire, vraiment, ça peut être un trouble bipolaire.

Et là, des familles, vous les voyez. Donc, un patient qui a un trouble bipolaire, vous voyez que dans la famille, il y a d'autres membres qui ont un trouble bipolaire. Alors, les antécédents judiciaires aussi orientent.

Et surtout, les antécédents judiciaires à la même période. Parce que les accès maniaques, ils se font des fois à la même période. Et en général, ils se font en été.

Donc, si un patient vous rapporte peu de symptômes, mais il vous dit, la famille vous dit, par exemple, il est incarcéré chaque mois de juin, il est incarcéré, ou bien chaque mois d'août, ou

bien chaque année, dans cette période, ou bien à des occasions particulières, par exemple, pendant le Ramadan, pendant l'Eid Kibir, à chaque fois, il est incarcéré pendant cette période, cette périodicité de ces incarcérations, il peut vous orienter dans le diagramme cycle. Alors déjà, par rapport à la phase d'état, la présentation du malade peut nous orienter. Pour les gens qui sont passés dans le service, ou bien qui sont en cours, comment vous voyez un patient maniaque? Comment il va se présenter? Comment il se présente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire chez un patient maniaque? Oui? Oui? Oui, exactement.

L'habit n'est pas adapté à la situation et au lieu, même des fois n'est pas adapté à la saison. Donc il peut s'habiller de façon extravagante. Très bien.

Un contact familial. Donc vous la voyez déjà dans la salle d'entente, oui? Très haut temps. Un contact haut temps.

Oui, exactement. Déjà à l'entrée de la salle d'entente, vous voyez comment il est haut temps. Il attend à ce qu'il soit reçu de manière spéciale et à ce que les autres se lèvent pour la faire entrer, habillé de façon extravagante, avec des fois des couleurs flashants, des couleurs qui sont déflorescantes, un gros chapeau, des grandes lunettes, des bijoux, des chapelets des fois.

D'accord? Donc déjà ça attire l'attention. Donc la tenue, elle est extravagante. Parfois un désordre.

Pourquoi le désordre? C'est des maniaques, des accès maniaques. Il tient vraiment à ce que les choses soient bien faites, qu'il soit trop maquillé, bien habillé. Mais le désordre, c'est parce qu'ils sont hyperactifs.

Dans l'hyperactivité, il peut mettre rapidement les choses et il peut montrer sa terre qu'elle est en désordre. Parfois, il vient, comme je vous ai dit, torse nu, ou bien totalement nu. Totalement, parce qu'ils sont dans la désinhibition, dans la séduction aussi sexuelle, l'hypersexualité, et parce qu'ils peuvent être dilurants.

Par exemple, l'hypermimie, à l'opposé de l'hypomimie qu'on voit, ou bien de la mimie qu'on voit dans la dépression, un regard, mais vraiment le regard, il est brillant. Ça ne vous paraît pas évident, mais vraiment, nous, avec l'expérience, on peut voir ça. Dans le regard des personnes qui ont un trouble bipolaire, qui sont en axe maniaque, on peut le voir dans leur regard, un regard brillant.

Des rires intenses, des éclats de rire, vous l'entendez de loin. Et bien sûr, comme vous avez dit, le contact familial, il va commencer, il va saluer tout le monde dans la salle d'attente, comme s'il les connaissait. Il va vous saluer comme s'il vous connaît, vous aussi.

Avec des moqueries, quand vous posez la question, il va essayer de vous répondre avec des moqueries, il va essayer de vous répondre, comme on va le voir, avec des proverbes. Vous

donnez une question, il va vous répondre avec des proverbes. Toujours dans la présentation, parfois ils sont autas, et l'hypersynthonie.

Quand ils rentrent, ils sont attirés par tous les stimulus. Il est avec vous dans votre bureau, et il est attiré par tous les stimulus autour. Il peut se concentrer sur ce que vous dites, mais aussi attiré par ce qui se passe à l'extérieur.

Il va faire attention à ce qui se passe à l'extérieur, à ce que dit l'autre, à ce qu'il voit à travers la fenêtre, et à ce que vous dites vous. C'est ce qu'on appelle l'hypersynthonie. Synthonie, ça veut dire être attiré par tous les stimulus, faire attention à tous les stimulus.

Alors, le langage, c'est l'opposé de l'accent dépressif. La langue orée, c'est quoi la langue orée ? Monopoliser la parole. Il ne va pas vous laisser placer un mot.

Quand il est avec vous en consultation, il ne va pas vous laisser poser des questions, il ne va pas vous laisser parler. Et quand ils sont dans un groupe, c'est lui qui monopolise la parole. Et c'est connu.

Et ça aussi, c'est un symptôme que la plupart des familles détectent. Elle a commencé à dormir peu, et elle a commencé à parler beaucoup. L'obscénité, c'est facile pour eux de sortir des mots obscènes.

L'humeur, bien sûr, c'est l'exaltation, comme on a dit, c'est la joie morbide, c'est une joie morbide. Les personnes, des fois, même cette joie, ça leur fait peur. Ça vous arrive, des fois, que vous vous sentez très heureux, que vous vous dites que la joie n'est rien.

Vous vous sentez très heureux. Il y a que maintenant 2019, mais ça va passer. C'est des hauts, des bas.

Savourez les moments positifs, savourez les moments où vous êtes bien, pour pouvoir dépasser les moments difficiles. Donc, eux, ils ressentent cette joie, et ils vous disent que c'est une joie extrême. Je n'ai jamais senti cette joie.

C'est une joie vraiment extrême. Alors, bien sûr, l'optimisme, l'insouciance. Ils sont insoucians, donc ils peuvent s'habiller de façon extravagante, même nus.

Ils peuvent être en contact avec tout le monde, avoir un contact familial, dépenser beaucoup d'argent, acheter beaucoup de choses. Vraiment, l'insouciance. La virtualité et l'instabilité, le changement de l'humeur.

Des fois, c'est à l'extrême, des fois, à minima, des fois même, ils peuvent passer dans l'autre version, dépressif, mais leur humeur, elle change. Elle est versatile. Sur le plan intellectuel, comment ça vient, cette logorée ? C'est parce qu'il y a une taquipsychie.

Ça passe rapidement. Les pensées, les idées, défilent rapidement. C'est ce qu'on appelle l'effuit des idées.

Et elles défilent rapidement, et le balade, on va le voir en pratique, par cette logorée, par des réponses, par des associations, par assonances, par des jeux de mots, par des proverbes. Il va utiliser des proverbes. Et là, l'effuit des idées.

Les idées défilent rapidement. Les idées défilent. C'est pour ça qu'il parle beaucoup.

Parce qu'il n'arrête pas, il ne peut pas les arrêter. Et il le dit. Le patient peut les verbaliser.

J'arrête pas d'arrêter mes pensées. J'arrête pas d'arrêter mes idées, j'arrive pas. Elles défilent rapidement.

Alors, comment on pose la question ? Quand tu te sens dans la tête, tes idées se dirigent. Tu te dis, oui, tes idées se dirigent, il y a beaucoup d'idées. J'arrive pas à les lier.

Et c'est pour ça qu'il peut sortir des fois un discours qui est incohérent, comme si on a entre guillemets, j'insiste, du coq à l'âne. Parce que vous allez voir le discours incohérent. Le coq à l'âne, on le trouve dans l'esquizophrénie.

Dans l'autobus polaire, son discours, il reste cohérent. Le patient, c'est vrai qu'il est logorique, mais le discours, il vous raconte les choses de façon cohérente. Sauf quand il est délirant.

Mais avec cette logorie, on a l'impression qu'il est incohérent. Moi, je vous dis en arabe, une patiente qui m'a répondu avec une association par assonance. Alors, comme je vous ai dit, on leur pose la question.

Je l'ai retenue, cette phrase. À chaque fois, je la répète pour les étudiants. Parce que vraiment, c'est ça l'association par assonance.

C'est trouver des mots qui ont le même sens, comme ça. D'accord ? Là, c'est des réponses comme ça. Et il peut, au cours de tout l'entretien, vous répondre par des réponses comme ça.

Les proverbes, c'est quelqu'un qui a cette capacité. Et des fois, parce qu'on va voir l'autobus polaire, ils ont la créativité. C'est des gens qui peuvent être créatifs.

C'est des artistes, des peintres, qui sont créatifs au moment de l'accès. Et eux, ils peuvent vraiment trouver des réponses sous forme de proverbes. Attention, leur attention.

C'est vrai, les personnes sont attirées par plusieurs choses, mais leur attention, elle est dispersée. Il n'y a pas vraiment une vraie concentration. Si quelqu'un, par exemple, est là au cours, c'est vrai qu'il va m'écouter, mais en même temps, il est attiré par ce que disent les autres, si quelqu'un apparaît, il va voir si quelqu'un va apparaître ici, parce qu'il se passe à l'extérieur.

Donc, il n'y a pas vraiment une vraie concentration. Il peut y avoir des idées délirantes. Et les idées délirantes, comme dans le trouble dépressif, elles sont congruentes à l'humeur.

Ça veut dire quoi congruente à l'humeur? Idées délirantes congruentes à l'humeur. On l'a dit la dernière fois. Oui, elles vont dans le même sens que l'humeur.

Un patient déprimé, quel type d'idées délirantes va avoir? Délirantes sur lui, sur ce qui se passe. Oui, il va être suicidaire, mais les types d'idées délirantes. Suicider, ce n'est pas un délire, c'est conscient qu'il veut s'en finir avec la vie.

Tout le monde veut persécution, très bien. On me veut du mal. Ça, on va trouver aussi dans le... On me veut du mal parce qu'il est triste.

Je ne vauds rien. Je suis une ruine. Ma famille a honte de moi.

Que des idées négatives. J'entends des voix qui m'insultent, qui me disent que vous êtes un âne, que vous n'êtes rien, que vous êtes un chien. D'accord? Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent.

Donc, que des idées négatives. C'est congruent à l'humeur. Le mégalomane, qu'est-ce qu'il va dire quand on met des idées délirantes? Il est joyeux.

Je suis le plus fort, le plus beau, le plus riche, le meilleur scientifique. Vous êtes médecin, vous me posez des questions. Moi, je connais tout.

D'accord? Je peux soigner des malades sans prescrire de médicaments. Par exemple, c'est ça qu'il va vous dire au cours de l'entretien. Il va essayer de se moquer de vous, de vous taquiner, de vous dire des choses comme ça.

Je suis le meilleur. Avec leur aspect hautain. Donc, il va dans ce sens.

Il va commencer, vous êtes nul. D'accord? Je suis immortel. Ça, c'est dans le sens de la mégalomanie.

Je suis le meilleur. Je suis le meilleur scientifique. Et avec la mégalomanie, il y a toujours de la persécution.

C'est parce que je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus riche, qu'on me veut du mal. Il y a aussi de la persécution qui peut s'y associer. D'accord? Une surestimation de soi, le meilleur, toute puissance, il peut toujours réussir avec des projets multiples.

Il y en a qui font des projets multiples, qui dépensent de l'argent pour des projets multiples et qui peuvent avoir par la suite des conséquences économiques graves. À côté de ça, comme dans les troubles dépressifs, il y a des troubles instinctuels, l'insomnie sans fatigue, c'est la caractéristique, l'hyperphagie avec amigressement. Pourquoi hyperphagie avec amigressement? Hyperactif, très bien.

Même s'il mange, hyperactif. Si vous voulez, il fonctionne à son allure. Hypersexualité et séduction.

Et ça, ça peut leur causer des problèmes, surtout pour les femmes. On peut profiter des femmes, abuser d'eux. Imaginez une femme qui a... Et ça, malheureusement, je vois sur les réseaux sociaux des fois, les gens, ils se moquent ou bien rigolent par rapport à certaines femmes qui se présentent comme ça pour parler.

Même des fois, des influenceuses, ou bien comment on les appelle, vous les voyez des fois avec leurs tenues extravagantes, qui se maquillent beaucoup. Il y a une qui est très connue qui se maquille beaucoup, tenue extravagante, et qui parle comme ça d'une manière un petit peu maniérée. D'accord? Donc, les gens, ils profitent de ça.

Il y a même des journalistes qui sont partis chez cette personne à poser des questions, à rigoler, à montrer ça, et parler, dire je parle français, moi je parle très bien français. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc là, c'est malheureux parce qu'on profite de son statut de malade.

Et les gens ne se posent même pas la question. Est-ce que c'est normal? D'accord? Donc là, il y a aussi des femmes qui ont, c'est vrai, qui ont cette tenue extravagante, bien maquillée, avec vraiment des tenues, des jupes courtes par exemple, ou bien serrées. Là, les gens, ils peuvent abuser de ces femmes-là.

Donc, avec l'hyper, ils ont cette hypersexualité, et avec l'hypersexualité, ils peuvent avoir le risque d'avoir des grossesses à risque. Alors, on est là? Oui, l'hypersexualité. Ils peuvent avoir des grossesses à risque.

D'accord? Donc, les femmes, vraiment, quand ils viennent, on accède. De toute façon, nous, les femmes, quand ils viennent, on les hospitalise automatiquement le temps qu'ils se stabilisent, et on peut les adresser à leur famille. À la rigueur, les hommes, on les fait sortir tout seuls, et des fois même, on peut ne pas les hospitaliser, mais les femmes, il y a ce risque.

Alors, par rapport aux autres troubles de comportement, il peut y avoir des problèmes graves de troubles de comportement, les dépenses exagérées, et il y en a qui ont perdu tout leur capital financier. Moi, je me rappelle un patient qui est bipolaire, son père, il est très riche, ils ont des hôtels, et lui, un jour, il est venu chez moi à la consultation, il a ramené un sac en plastique, un sac noir, il a ramené un sac à dos avec un sac en plastique noir. Donc, il était suivi chez moi, donc je l'ai vu, il était vraiment stabilisé, pas vraiment en accès, mais il est venu, juste on l'a vu en consultation, j'ai renouvelé l'ordonnance, on a parlé, et tout, après, il est parti, et son père a appelé, est-ce qu'il est venu ? Oui, il est venu.

Est-ce qu'il a amené avec lui des sacs ? Oui, j'ai dit, il a amené un sac noir, un sac de poubelle noir, je n'ai pas fait attention, il m'a dit, il a pris toute la recette de l'hôtel et il est parti avec. Donc,

il peut la dépenser en un jour. En un jour, le minimum, les patients peuvent dépenser 50 000 dirhams, 100 000 dirhams, vraiment de grandes sommes, et il y en a qui vont donner des chèques, carrément des chèques, à Blanc, et ils vont perdre tout leur capital.

Ça, ça peut entraîner des conséquences, on va voir dans la psychéducation qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure pour pallier à ça. Alors, l'hyperactivité, on en a parlé, l'agitation et l'agressivité, ils sont ludiques, ils sont dans la salle d'attente, en train de chanter, de danser, de se déguiser, comme j'ai dit, ils peuvent se dénuder carrément, dans la rue, ou bien venir à la salle, à la consultation. Donc, dans cette hyperactivité, ils peuvent commencer plusieurs projets sans terminer un.

Commencer le premier, ne pas le terminer, commencer un deuxième, ne pas le terminer, même dans le milieu de travail. Ils peuvent ranger, déménager, à chaque fois qu'ils font un projet, à chaque fois qu'ils commencent une activité, ils peuvent ne pas la terminer et passer à une autre. Ils peuvent avoir aussi des voyages pathologiques et des voyages à pied.

On a reçu des passants qui sont venus des autres villes et des passants de notre ville qui sont partis à pied vers les autres villes. Et bien sûr, avec cet accès, comme vous voyez, tous les symptômes qu'il y a, il peut y avoir de l'absentéisme ou bien du relâchement professionnel. Pourquoi je vais aller au travail ? Je n'ai pas besoin d'eux.

Qui a besoin de moi ? S'ils ont besoin de moi, ils doivent venir me chercher ou bien ils doivent venir chez moi, je vais leur dire ce qu'il faut faire. Et puis au travail, il ne va pas y avoir du respect de l'hierarchie. Donc là, il va se bagarrer avec son supérieur.

C'est lui qui doit me respecter. Je suis le meilleur. Je suis mieux que lui.

Donc ça, c'est des choses qui peuvent entraîner des problèmes professionnels. Et comme on a dit, une désinhibition financière, perdre tout son argent, ils sont aussi des manipulateurs. Donc il y a de la séduction, de la manipulation, de l'euphorie, de l'agitation, de l'excitation, et de la manipulation.

Ils peuvent manipuler le médecin. Vous voyez quelqu'un qui va bien parler, qui va être gentil, pour demander par exemple la sortie, pour ne pas être hospitalisé. La manipulation, ça c'est quelque chose de très fort qu'ils ont.

Et bien sûr, quand ils ont vraiment la pathologie tropéolaire, c'est un trouble où les patients sont inconscients de leur trouble. En général, c'est rare qu'ils viennent eux-mêmes quand ils détectent les premiers symptômes et qu'ils se sentent bien éduqués, qu'ils ont reçu une psychéducation. Mais en général, c'est la famille qui les amène.

Ils ne tiennent pas, ils ne restent pas, ils ne peuvent pas tenir et rester à la maison. Alors l'évolution, ça évolue vers la répétition des accès. On parle de trouble bipolaire type 1 à partir du

deuxième accès, parce que quand on reçoit un patient en accès maniaque, c'est un accès qui survient de façon brutale, avec l'euphorie, l'excitation, la joie, la grande agitation psychomotrice.

On pense à quoi au début ? Quel est le diagnostic ? S'il vient la première fois, sans antécédent ? Oui, ça peut être avec une substance, c'est comme on appelle le premier accès avec une substance. Qu'est-ce que vous avez fait avec un professeur à Adélie comme cours ? Trouble de conduite alimentaire, quoi d'autre ? L'esprit, d'accord. Alors, quand c'est post-toxique, on parle d'accès psychotique aiguë, post-toxique, d'allure maniaque.

Quand ce n'est pas post-toxique, on parle d'accès psychotique aiguë, d'allure maniaque. On lui donne la chance du premier accès psychotique aiguë, on va voir l'évolution. Est-ce que ça ne va pas se répéter ? Si ça se répète, bien sûr sans la prise de toxique, là on peut parler d'un trouble bipolaire type 1. Alors, les accès surviennent souvent suite à des facteurs déclenchants.

Les facteurs déclenchants les plus fréquents, c'est des facteurs de stress, que ce soit le stress par rapport aux événements extérieurs, mais surtout le stress par rapport à la famille, le stress des parents, le stress causé par les parents qui sont derrière le patient à l'obliger à faire des choses, alors qu'ils ne savent pas qu'il est malade par exemple. C'est cette relation entre les parents et le patient qui peut engendrer un facteur de stress. Et bien sûr, il y a le stress causé par les événements extérieurs, un examen, le stress au travail, les grandes catastrophes par exemple, ça peut déclencher des accès.

Et les troubles surviennent en général, il y a cette caractéristique de périodicité. Il est évident quand le patient fait un accès par an, mais il n'est pas évident si le patient fait trois, quatre accès par an, donc on ne voit pas vraiment la période. Alors le risque, parmi les facteurs de risque liés à la manie, donc le plus important, donc il y a un retentissement handicapant pour le sujet, c'est la désinsertion socio-professionnelle.

Au niveau familial, imaginez un père de famille qui a ce trouble-là, l'agitation, l'hyperactivité motrice, l'allégorie, l'irritabilité, les dépenses exagérées, un petit peu l'agressivité, donc avec ses enfants, ça rend la famille instable. Sur le point professionnel, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester stable en place. Et puis le conduit à risque, comme on a dit, les rapports sexuels non protégés, pour les deux, mais surtout pour les femmes, ça peut entraîner des grossesses à risque.

On a des femmes bipolaires qui ont accouché quatre, trois, cinq fois, et on ne peut pas les empêcher. Il y a l'allégation des troubles, mais des fois il faut l'accord de la famille, l'accord du patient. Il y a une patiente qui a refusé l'allégation du trouble.

Il y a aussi l'errance, comme on a dit, il peut y avoir des voyages pathologiques qui peuvent aller jusqu'à l'errance. Le patient va errer dans les rues, et avec cette hyperactivité, il peut aller jusqu'au vagabondage. Donc il dort dans la rue, il demande à manger dans la rue, ça peut aller des fois jusqu'au vagabondage.

Dilapidation, ça on l'a dit, du capital financier, perdre tout leur argent. Comportement hétéroagressif qui peut aller jusqu'au suicide ou bien l'homicide. Un patient anaxémanique qui se croit le meilleur scientifique qui a fait des inventions, il croit qu'il a fait des inventions.

Il pense que quelqu'un lui a volé son invention. Il va sûrement aller le tuer, par exemple. D'accord ? Moi, dans ce risque lié à la manie, j'ai deux cas qui m'ont marquée dans ma vie professionnelle.

Une patiente qui était suivie pour un trouble bipolaire, que j'ai suivie, c'était en France. Elle avait deux enfants, un enfant qui avait 11 ans et un 7 ans. Elle était anaxémanique.

Elle a fait un suicide altruiste avec ses deux enfants. Elle a pris beaucoup de médicaments, elle a donné des anxiolytiques à ses enfants et les a empêchés de respirer avec des coussins. Parce que les enfants, ils ont pris des benzodiazépines, ils se sont endormis, elle les a empêchés de respirer avec des coussins.

Les enfants sont décédés et elle est restée. Vous n'imaginez pas, à chaque fois que je vois cette patiente, ce que je ressens. D'ailleurs, quand j'étais en France, quand je faisais la visite, normalement je rentre moi, avec les externes, pour vous dire que vous, vous avez de la chance, vous avez vraiment une prise en charge.

Alors à l'étranger, je vous dis, je suis passée par des services de psychiatrie, c'est rare qu'on fait des visites avec les étudiants, comme vous avez la possibilité de voir beaucoup de malades, vous êtes dans les services. Donc quand je fais la visite, il y a les externes avec moi, il y a l'assistante sociale, il y a la psychologue, il y a la surveillante et des fois, il y a des personnes qui ne peuvent pas entrer, qui n'osent pas entrer, avec moi. Donc je rentre, la première fois que je suis rentrée chez elle, elle a commencé à me parler de ses enfants.

Moi je n'ai pas encore vu le dossier. Je croyais que ses enfants étaient encore en vie. Elle parlait de ses enfants comme s'ils étaient encore en vie.

De son histoire, un petit peu, et je ne vous dis pas la femme comme elle est, une très belle femme, mignonne, les cheveux très courts, une blonde avec les yeux verts, très calme, très douce. Elle me parlait de ça et après quand j'étais allée voir le dossier, à chaque fois que je rentre chez elle, je sors désarmée, vraiment, quand elle parle de cette histoire. Et c'est qui qui vient lui rendre visite ? Son mari, le père de ses enfants, et son beau-père, le père de son mari.

Vraiment. C'est vraiment très touchant. On a des cas comme ça.

On a des cas de suicides altruistes comme ça. Des gens qui vont prendre du risque avec leur famille. Le deuxième cas, c'était un médecin, un médecin bipolaire.

Il avait dans sa famille quatre médecins qui ont un trouble bipolaire et qui se sont suicidés. Les quatre. Elle était hospitalisée pour le stabiliser.

Elle était en axe dépressif, suicidaire. Elle était hospitalisée pour le stabiliser. Elle était déjà sous trois médicaments.

Des fois, c'est difficile, pour vous dire la difficulté. Elle était hospitalisée pour qu'on lui introduise un quatrième médicament. Le quatrième médicament, c'est un médicament qu'il fallait introduire progressivement, en comprimé, toutes les deux semaines.

Alors, moi, je lui ai mis le traitement le premier jour. Lui, il s'attendait à ce que j'augmente chaque jour. Le deuxième jour, je ne lui ai pas donné.

Le troisième jour, après, il est venu. Pourquoi vous ne m'avez pas donné le médicament ? Je dois prendre. Je lui ai dit, le protocole, c'est toutes les deux semaines.

Il m'a dit, ah non, moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité de fermer mon cabinet pendant deux semaines pour attendre. Je n'ai que deux semaines où je peux fermer mon cabinet. Je dois reprendre mon travail.

Donc, on doit vraiment augmenter rapidement. Bien sûr, quand je vis avec le chef de service, puisqu'il était hospitalisé, on a pris le risque. Et puis, le médicament, pourquoi il faut l'augmenter progressivement, c'est de la motrigine comme l'intégrétole.

On augmente progressivement parce que ça donne des effets cutanés qui sont dangereux, qui peuvent être mortels. Le syndrome de la haine, vous connaissez le syndrome de la haine ? Donc, il peut être mortel. Et il m'a dit, moi, je suis dermatologue.

À chaque fois qu'il y a un problème, je vais vous le dire. Ne craignez rien. Avec l'avis du chef de service, on a commencé à augmenter rapidement tous les deux jours, mais on surveillait.

Des fois, c'est difficile et c'est pénible. Que ce soit pour la femme ou pour l'homme, la vie peut être un petit peu pénible. C'est pour ça, j'insiste sur le traitement préventif, la psychoéducation qui peut rendre la vie normale.

Alors, il y a le comportement hétéroagressif qui peut aller jusqu'au homicide ou bien le suicide, les développements d'addiction qui vont aggraver le problème. L'alcool, toutes les addictions dont de l'excitation, dont de l'euphorie, dont de l'hyperactivité, dont de l'agitation psychomotrice, c'est encore chez un patient bipolaire qui a déjà ça, ça va aggraver le problème et même le risque suicidaire, ça s'aggrave. Dans les formes les plus agitées, on peut avoir de l'épuisement, de la dénutrition, de la déshydratation parce que le patient, il peut être et peut avoir sa part l'hyperactivité et parce qu'il oublie de manger, il oublie de boire.

Tellement il est hyperactif, il oublie de manger et de boire. Là, c'est juste pour rappeler les critères DSM, vous allez voir que c'est les mêmes critères dont on a parlé. Une période, déjà, il y a la notion du temps comme dans les troubles, les états dépressifs, on a parlé de deux semaines

et si c'est une semaine où on a l'humeur élevée de façon anormale et de façon persistante, donc c'est tous les jours et bien sûr au moins trois des symptômes suivants.

Donc soit B1, B2, B3, B4, là c'est le symptôme qu'on a vu, la mégalomanie, diminution du sommeil, l'insomnie, fuite d'idées, distractibilité, l'allégorie et puis l'augmentation des activités, l'hyperactivité, des activités agréables mais dommageables avec des dommages et bien sûr ce n'est pas une altération qui est expliquée par la prise de substances ou bien par une maladie générale. Si c'est un trouble bipolaire, si c'est un accès maniaque qui est dû à une maladie cérébrale, on va dire que l'accès maniaque secondaire a un problème cérébral, par exemple une tumeur frontale. Une fois qu'on traite la tumeur, l'accès maniaque va disparaître.

Si c'est post-toxique, on va dire que c'est un accès maniaque post-toxique. Une fois que le patient arrête le toxique, l'accès maniaque va disparaître. Alors l'épisode dépressif, je vais me répéter, c'est ce qu'on a dit, j'ai mis quand même les symptômes ici, comme ça, ça vous fait une révision.

Quand vous êtes devant l'accès maniaque, vous allez réviser aussi les symptômes dépressifs. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Et c'est à l'opposé de tout ce qui est accès maniaque comme symptôme.

C'est l'image au miroir si vous voulez. Tout ça. Alors on arrive aux formes cliniques, comme je vous ai dit, les formes les plus caractérisées, c'est le type 1, c'est la répétition d'accès maniaque avec ou sans accès dépressif.

Le type 2, c'est l'alternance d'épisodes dépressifs majeurs et d'épisodes hypomaniaques. Donc pour pouvoir dire que c'est type 1 ou type 2, vous devez pouvoir diagnostiquer l'hypomanie. On va voir les symptômes.

Type 3, c'est quand on a un virage maniaque sous antidépresseur. Des fois, vous recevez un malade déprimé en accès dépressif. Vous faites bien votre entretien, vous ne trouvez pas d'accès hypomaniaque, pas d'antécédents familiaux ou chimiques, vous ne trouvez rien du tout.

Donc, vous mettez le patient sous antidépresseur. Et comme le virage maniaque, c'est un effet secondaire, il peut faire un virage maniaque, même si vous avez bien fait votre entretien. Ce qu'il faut faire quand vous démarrez le traitement antidépresseur, quand vous avertissez le patient, par exemple, quand vous mettez un patient sous tes grétoles, qu'est-ce que vous lui dites? Surveillez quoi? C'est-à-dire? Non, non, quand vous êtes devant un patient qui a une épilepsie et vous le mettez devant, et vous le mettez sous tes grétoles, quel est le symptôme qu'il doit surveiller comme effet secondaire grave? Les? Très bien.

Vous lui dites à chaque fois que vous avez une lésion cutanée, il faut arrêter le traitement et venir me voir. Parce que l'effet secondaire mortel, c'est le syndrome de la haine. C'est des brûlures cutanées.

Vous avez déjà vu un syndrome de la haine? C'est qui qui l'a vu? Est-ce que vous pouvez l'oublier? On ne peut jamais l'oublier, ça reste dans notre tête. C'est des brûlures cutanées de tout le corps, comme si vous faites une brûlure deuxième, ou bien troisième degré. D'accord? Alors, comme pour les autres médicaments, vous avertissez les patients des effets secondaires graves, aussi, quand vous donnez un antidépresseur, vous dites au patient, si vous avez, si jamais il y a une amélioration rapide et intense au bout d'une semaine, il faut arrêter le traitement et venir me voir.

Parce que le traitement antidépresseur, vous allez le voir dans la thérapeutique, ça n'améliore pas l'état en une semaine, deux semaines. Et si ça améliore l'état, c'est progressivement, tout doucement. Le minimum, c'est trois semaines.

Mais en général, c'est un mois, un mois et demi. D'accord? Donc, s'il y a une amélioration spectaculaire au bout de deux jours, une semaine, alors là, c'est un signal d'alarme. Il faut arrêter le traitement.

D'accord? Ce n'est pas que vous êtes le meilleur médecin, mais parce que des fois, il y a des malades qui viennent vous dire, vous êtes le meilleur. Je me sens vraiment joyeux, euphorique, excité, hyperactif, tout a disparu. Votre traitement est un traitement miracle.

Oui, mais là, vous faites un virage maniaque. Arrêtez le traitement et vous passez au tube régulateur. D'accord? Et des fois même au neuroleptique.

Donc, le trouble cyclotimique, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va voir la cyclotimie, c'est juste vous donner la définition. On a parlé de la dysthymie, c'est un épisode dépressif d'intensité modérée à minime qui se répète au bout, qui continue au bout de deux ans. Ici, la cyclotimie, c'est la récurrence d'accès hypomaniaque et d'accès subdépressif, pas des épisodes dépressifs majeurs.

Si c'était des épisodes dépressifs majeurs, on est dans le type 2. Dans le type, oui, 2. D'accord? Donc ici, c'est des accès subdépressifs, ça veut dire des accès dépressifs mineurs qui vont durer pendant deux ans. C'est la cyclotimie. Les états mixtes, au cours du même accès quand on dit mixte, ça veut dire les deux en même temps.

Les symptômes de l'état dépressif associés à l'état maniaque ou hypomaniaque, tous les jours pendant au moins une semaine. Tous les jours, les deux symptômes qu'on a. Il est joyeux, il est triste, il est euphorique, il est calme, il est ralenti, il est hyperactif la même journée pendant une semaine. C'est ce qu'on appelle l'état mixte.

Pourquoi il faut différencier tous ces états? Parce que le traitement est différent. Les troubles à cycle rapide, c'est au-delà de 4 épisodes par an. Aussi, il y a des tumeurs régulateurs beaucoup plus efficaces pour le cycle rapide que pour les autres.

Les autres formes, c'est les équivalents de troubles bipolaires. C'est l'alcoolisme périodique. Il y a des patients qui vont s'alcooliser de façon massive pendant une période.

Il faut creuser, chercher ce qu'il y a derrière. Ça peut être un trouble bipolaire derrière. Il y a normalement le trouble bipolaire quand il vient, c'est l'excitation, c'est la joie, c'est l'euphorie, c'est l'hyperactivité psychomotrice, c'est l'allégoire, c'est le temps hautain, c'est les moqueries, c'est les rires, c'est l'hypersintonie, c'est les dépenses exagérées, les projets multiples.

Ça reste un petit peu... Il n'y a pas d'éléments différents. Des fois, il y a des symptômes psychotiques, des symptômes de délire, des voix qui lui disent vous êtes le meilleur, vous pouvez sauter du septième étage, rien ne va vous arriver. Vous pouvez rouler à 200 km à l'heure, rien ne va vous arriver.

Vous pouvez poignarder votre ami, il ne va pas mourir. Vous faites des miracles, vous avez par exemple, je ne sais pas quoi, un pouvoir à faire revivre les gens qui sont morts. Donc ça, c'est des idées différentes, psychotiques.

Et il peut même aussi entendre des hallucinations. Et il y a des fois la manie chronique qui va durer, même avec les traitements, ça ne se stabilise pas. Ça, c'est les cas rares.

Heureusement, ça se stabilise. Alors, pourquoi il faut connaître l'hippomanie ? Parce qu'il n'y a pas de signe de sévérité. Les gens fonctionnent normalement, peuvent vivre normalement et peuvent ne pas en parler du tout.

Il n'y a pas d'éléments psychotiques. Dans l'hippomanie, il n'y a pas de délire et il n'y a pas d'hallucination. Et il ne nécessite pas l'hospitalisation.

En général, le sujet peut tenir chez lui. Et bien sûr, le changement est observé par l'entourage, mais les gens vous disent « Oui, mais il est connu comme ça depuis longtemps. Oui, mais tout le monde le connaît.

Il est comme ça. » Tout le monde aimerait être comme ça, mais ça ne pose pas de problème, pas de conséquences. Alors, les symptômes, ils ne vont pas être évoqués spontanément.

Si vous ne posez pas de questions, ils ne vont pas être évoqués spontanément. Et bien sûr, c'est ça Les symptômes ne sont pas dus à la prise de substance ni à une maladie médicale autre. Voilà comment ce sont ces gens.

Ils dorment peu, cinq heures, ça leur suffit. Et ils sont hyperactifs. Imaginez quelqu'un qui dort cinq heures.

Ça veut dire qu'il peut se réveiller à six heures, cinq heures du matin et depuis, il est actif. Il va y avoir beaucoup de rendement. Alors, plus d'énergie, plus de confiance en soi.

Ce sont des gens qui peuvent parler en plein public, qui peuvent faire des projets, plus de motivation au travail, plus d'activité sociale, surcroît d'activité physique. Il fait beaucoup de sport. S'il se réveille à cinq heures du matin, il peut faire déjà son sport après aller à son travail.

Plus de projets et d'idées. Ce sont eux qui donnent des idées dans les réunions, des idées créatives. Et c'est là où on va trouver plus d'artistes, plus de... Les artistes, soit au cinéma, soit des artistes, des peintres.

Moins de timidité, plus bavard. Ce n'est pas la logorée. Ils vont monopoliser la parole, mais plus sociable, plus bavard, facile à aborder les autres.

Plus optimistes, euphoriques. Ils sont optimistes. Ce n'est pas la mégalomanie, mais ils sont quand même optimistes et euphoriques.

Des rires, des calembours. Donc, des pensées plus rapides. Ce sont eux qui vont donner des idées dans les réunions.

Plus de déplacements, de voyages. Ils sont tout le temps prêts à voyager, à rendre service. Ils prennent des risques, des risques, même pour les projets, mais pour faire entrer, par exemple, de l'argent dans des projets, financer des dépenses excessives.

Et là, c'est quelqu'un qui a un boulot, quelqu'un qui a un boulot, il doit trouver. Alors, des comportements déraisonnables dans les affaires. Il peut prendre des risques dans les affaires.

Et ils peuvent réussir. D'accord? Plus d'impatience et d'irritabilité. Concentration diminuée.

C'est vrai parce qu'ils sont aussi éparpillés. Augmentation des pulsions sexuelles. C'est pas l'hypersexualité non protégée.

Mais ils font attention. Ils sont hyperactifs sexuellement. Et bien sûr, ils prennent beaucoup de de excitants.

Alcool, café, nicotine et drogue pour garder le même état. Mais ces gens-là, ils sont plus à risque de faire des virages maniaques s'ils prennent des excitants. Ça se comprend.

Et bien sûr, ils sont plus à risque de faire un virage maniaque s'ils prennent des antidépresseurs. Alors, c'est pour ça qu'il faut connaître l'accès épomaniac parce qu'il ne va pas être révélé spontanément. Comme j'ai dit, ils ne sont pas rapportés spontanément.

Ils ne sont pas perçus comme pathologiques. C'est des hommes biens. Des gens qui travaillent à l'extérieur, qui travaillent à la maison.

Un homme comme ça, une femme comme ça, le mari, il est tranquille. Il travaille en même temps à la maison, il s'occupe des enfants et il travaille à l'extérieur. Un homme comme ça s'occupe des

enfants, travaille à la maison, travaille à l'extérieur, des activités associatives et puis, il travaille beaucoup pour ramener de l'argent.

C'est quelqu'un qui est vraiment non reconnu comme pathologique. Perçu parfois comme socialement avantageux et positifs. Et vous voyez, il y a des hommes politiques qui sont comme ça.

Non associés à la souffrance, il n'y a pas de souffrance. Quand il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de demande de consultation, pas de demande de soins. Et bien sûr, pour vraiment avoir le diagnostic, il faut bien poser les questions et bien insister et chercher les informations auprès de la famille.

Devant un patient qui se présente en axé maniaque, on est obligé d'insister. Des fois, on insiste pour poser le compte à patient et là, en axé maniaque, une dépression sans problème chimique derrière. Autre, on est tranquille.

On donne notre dépression et on est tranquille. Vis-à-vis de l'AMM, on est tranquille. Quand on est devant un patient en axé dépressif, on commence à creuser.

En même temps, on creuse en même temps qu'un goulard et ça pose un problème dans le traitement. Des fois, c'est difficile. L'évolution, on va voir son traitement, c'est les risques.

Tous les risques qu'on a vus tout à l'heure, c'est le suicide, c'est les actes médicaux légaux, homicide, agressivité, irritabilité, des problèmes avec les supérieurs, c'est les drogues, c'est les problèmes familiaux, les problèmes sociaux, les problèmes professionnels, c'est la délapidation du capital économique, il perd tout son argent et c'est une biographie orageuse. Ils font beaucoup de passages dans les commissariats, dans les bagarres, ils font beaucoup d'incarcération et de façon périodique. Bien sûr, les axés, ils vont s'aggraver et chaque axé va précipiter le prochain axé.

Au lieu de faire un axé tous les deux ans, quatre ans, il va faire plusieurs axés par an. Son traitement, voilà les chiffres qui parlent. Suicide 19%, le risque de chômage, de divorce, le risque d'addiction qui est multiplié par six.

Et c'est des chiffres qui sont très alarmants. C'est très élevé comme chiffre. Divorce jusqu'à 73%.

Avec le traitement, c'est ce qu'on va faire avec la psychoéducation, ça diminue la fréquence, l'intensité, la durée des axés, ça espace les axés et il y a même possibilité de disparition et avoir une vie normale. On a des médecins avec nous qui sont bipolaires. Ils font des rechutes d'intensité moyenne, mais ils fonctionnent normalement et travaillent.

Des spécialistes comme des généralistes, on connaît des architectes, on connaît des avocats, il y a des ingénieurs, ça touche tout de nouveau. L'avantage avec les trop bipolaires, c'est que les gens peuvent mener une vie normale avec le traitement préventif. La schizophrénie aussi, mais

c'est plus fréquent avec les trop bipolaires.

Le pronostic est meilleur par rapport à la schizophrénie. Alors les facteurs de gravité, il y a des facteurs qui sont liés aux patients ou bien à la maladie elle-même. L'âge précoce du début, le nombre d'épisodes antérieurs et leur gravité, ça, ça va de soi, on l'a dit.

La présence de symptômes psychotiques, parce que l'accès maniaque, en général, on n'a pas de délire, il n'y a pas d'hallucination, fréquemment, mais s'il y a des délires et des hallucinations, le pronostic est mauvais. L'existence d'une personnalité antérieure pré-morbide, la personnalité irritable, agitée, agressive, surtout la personnalité antisociale. Comorbidité avec des conduites addictives, comme je vous ai dit, les drogues donnent les mêmes symptômes que l'accès maniaque.

Si un patient bipolaire prend les drogues, ça va aggraver ses symptômes, ou bien, il peut les déclencher, l'influence des événements négatifs de vie, les événements surtout stressants. Alors, par rapport à la prise en charge, la mauvaise observance du traitement, ça, c'est des choses qu'on peut contrôler. L'utilisation itérative d'antidépresseurs, c'est pour ça que j'insiste, avant de démarrer un antidépresseur, bien faire votre entretien.

En particulier les traits cycliques, c'est ceux qui donnent beaucoup plus de virages. L'errance diagnostique devant des tableaux atypiques. Non, il n'y a que le sommeil qui est réduit, mais il est calme.

Non, il n'y a que les dépenses exagérées, mais il n'y a pas ça. Donc, si on tarde à bien chercher et à trouver les symptômes, on a vu dans le dessin, on n'a pas besoin du tableau complet. Il ne faut que trois des symptômes posés pour poser le diagnostic.

Les limites d'efficacité des tumeurs régulateurs ainsi que leurs effets secondaires. Des fois, les patients ne vont pas prendre le traitement à cause des effets secondaires. Et des fois, les tumeurs régulateurs sont limités dans leur efficacité.

Donc, on est devant une impasse, des fois. C'est rare. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est rare, parce que maintenant, il y a de nouveaux traitements et les traitements, ils sont bien tolérés et ils sont efficaces.

Alors, le diagnostic différentiel devant un trouble bipolaire, d'abord, quand on est devant un trouble unipolaire, quand vous êtes devant des épisodes dépressifs qui se répètent, il faut se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un épisode maniaque ou hypomaniaque derrière? Il y a des choses qui vont vous orienter pour dire, attention, ce patient peut avoir des épisodes maniaques ou hypomaniaques. S'il y a davantage de culpabilité, s'il y a davantage d'idées suicidaires, ça, c'est des choses, vous allez voir, on va les trouver dans la dépression.

Mais s'il y a vraiment des choses de façon exagérée, s'il y a de nombreuses plaintes somatiques,

s'il y a de l'agitation, là, on s'approche des signes de la manie, de l'excitation, parce qu'il y a des dépressions agitées, de l'excitation, de l'oscillité, de l'irritabilité, de l'impulsivité, parce que la dépression, en général, c'est quelqu'un qui est calme, qui est ralenti, qui répond avec un temps de latence. Mais s'il y a des choses atypiques, là, il faut se poser la question. S'il y a de l'hypersomnie, de l'hyperfagie, c'est vrai qu'on l'a vu dans la dépression saisonnière, mais il faut, devant cette dépression, chercher s'il n'y a pas des troubles chimiques derrière.

S'il y a, chez la femme enceinte, en postpartum, vous allez voir les troubles de postpartum. Si on a des dépressions, il faut chercher, bien chercher, s'il n'y a pas des idées délirantes associées à l'infanticide et s'il n'y a pas des idées mégalomaniaques derrière. Je vais le tuer, je vais me retrouver avec lui, chez Dieu.

Même si je vais le tuer, je peux le refaire naître. Ou bien des idées comme ça. La saisonnalité aussi du trouble dépressif peut vous orienter.

Si on se sent moins bien en automne et mieux au printemps, donc cette saisonnalité, il faut bien chercher s'il y a des troubles chimiques derrière. C'est vrai que les gens se sentent bien le printemps, se sentent bien l'été, mais si c'est vraiment de façon saisonnière comme ça, périodique comme ça, il faut chercher s'il n'y a pas des troubles chimiques derrière. Il y a aussi ça, tous les critères là, c'est en fonction des études.

C'est des études qui ont trouvé plus de débuts précoces, par exemple, sur les patients déprimés qui ont fait des virages maniaques, plus de traits cyclotimiques, plus de biographies orageuses. Ce sont des études qui ont trouvé des études statistiques. Une histoire familiale de troubles chimiques, s'il y a une comorbidité avec l'alcool, une rémission trop rapide de l'épisode dépressif, ça aussi, c'est le plus classique, une insomnie aux hypnotiques, normalement, avec hypnotique ou bien avec les benzodiazépines, le sommeil, normalement, on doit avoir une amélioration du sommeil.

Mais s'il y a l'effet contraire, il faut se poser la question de conduite violente ou bizarre et s'il y a une résistance à plusieurs antidépresseurs. Ça aussi, c'est des éléments, tout ça, c'est des éléments qui orientent vers la bipolarité. Quand vous êtes devant un patient dépressif, vous avez ces cils-là, dites attention, ça peut être un patient bipolaire.

Les autres troubles à éliminer, un accès psychotique aigu. Est-ce qu'on est dans le trouble bipolaire ou bien on est dans l'accès psychotique aigu ? On est dans le premier. La schizophrénie des chimiques, ça, je ne vais pas détailler, mais vous allez le voir, c'est des patients qui ont, en même temps, des symptomatologies de schizophrénie avec des éléments chimiques, soit avec une dépression, soit avec des éléments de mégalomanie, de l'euphorie ou bien de l'excitation, mais en même temps, il y a les autres éléments diagnostiques de la schizophrénie, la discordance, la bizarrerie de comportement, les hallucinations, le délire, discordant, incohérent.

Alors, chose qui est capitale, c'est éliminer une pathologie organique autre. Toujours, j'ajoute le autre, parce que toutes les pathologies psychiatriques, c'est organique. Les plus fréquentes, les neurosyphilis, les toxiques, les tumeurs cérébrales, surtout les frontales et l'épilepsie.

Ces pathologies-là, elles donnent des accès typiques maniaques à un neurosyphilis. Je ne sais pas si vous avez vu des neurosyphilis dans les services de neurologie ou d'hermato. Vous pouvez les voir au début par des accès maniaques.

Une tumeur cérébrale au niveau frontal donne des tableaux typiques maniaques. Donc, au début, devant un accès de toute façon systématique, on fait un bilan, IUNO, NFS, TPHA, VDRL, HIV et TDM cérébral. Ça, on le fait systématiquement devant tout accès maniaque, le premier.

Et c'est médico-légal, il faut le faire le premier accès. Certains médicaments peuvent donner des troubles de l'humeur, que ce soit des troubles dépressifs ou des troubles maniaques. Les corticoïdes, par exemple, ils peuvent donner les deux.

Ça peut donner des dépressions, et surtout, quand on fait des bolus de corticoïdes. Et ça peut donner aussi des excitations maniaques. Les izoniazides, le traitement pour la tuberculose, il y a plein de médicaments qui peuvent donner soit des dépressions, soit des accès maniaques.

Donc, en tant que médecin, si vous êtes un médecin généraliste ou spécialiste, si vous avez des patients sous des traitements et que vous avez des symptômes maniaques ou bien des symptômes dépressifs, il faut chercher le traitement et ce qu'il donne ou qu'il ne donne pas. D'accord ? Comme vous ne pouvez pas connaître tous les effets secondaires de tous les médicaments, il n'y a pas de mal. Il ne faut pas dire aux patients non, non, ça ne donne pas ça, juste parce que vous avez honte de chercher.

Devant vous, il y a l'ordinateur et le Vidal vous cherche. Alors, sur le plan étiopathogénique, on a dit que l'étiologie n'est pas vraiment connue. Il y a des hypothèses étiologiques.

Déjà, au niveau génétique, les études ont montré que les jumeaux homozygotes, ils ont un jumeau homozygote qui a un trop bipolaire. Son jumeau a un risque de 75 % de présenter un trop bipolaire. Et ça, vous allez voir en consultation, il y a des mamans qui vont venir vous demander, j'ai mon fils qui est, par exemple, bipolaire, est-ce que son fils, son frère jumeau va devenir bipolaire ? Vous ne pouvez pas dire 100 % oui ni non.

Vous dites qu'il y a un risque. Comme le diabète. Des fois, on vous pose la question, mon père est diabétique, moi, je suis diabétique, est-ce que mon fils va être diabétique ? Pas forcément.

D'accord ? Aussi sur le plan génétique, pour les maladies psychiatriques, pas forcément. Donc, il y a un risque. Le risque augmente.

Vous voyez, pour les hétérozygotes, le risque est moins élevé que pour les homozygotes. Si les

parents, les deux parents, ont un trop bipolaire, le risque va jusqu'à 30 %. Il est beaucoup plus élevé que si un parent a un trop bipolaire. Donc, le risque augmente.

Approche, sur le plan neurobiologique, on constate qu'il y a un déséquilibre adrénoréno-cholinergique, un dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso sur un alien. Ça, c'est une hypothèse qui peut expliquer le trouble sur le plan biologique. Alors, sur le plan imagerie, on ne fait pas l'imagerie pour chercher ces lésions-là.

On les fait dans le cadre de la recherche. Les patients bipolaires chéquis, dans le cadre d'une recherche, on a fait l'IRM, on a trouvé des zones d'hyperfixation au niveau de la substance blanche, des lésions pseudovasculaires au niveau des régions frontales et temporales. Quand on a fait le PET scan, on a trouvé des diminutions du métabolisme au niveau du cortex préfrontal et au niveau des différentes régions, on a trouvé une perte de la balance d'activation.

Le préfrontal, parce que c'est le préfrontal qui fait tout ce qui est activité, activité, motricité, initiation. Alors, la prise en charge, donc il faut connaître les grandes lignes et surtout la psychoéducation, c'est capital. Elle permet d'établir et maintenir l'alliance thérapeutique et fournir, bien sûr, une éducation aux patients.

Ça, vous pouvez le faire vous-même, quelle que soit votre spécialité. Et bien sûr, parler des facteurs favorisants, stressants, essayer de les éviter, minimiser le dysfonctionnement fonctionnel, la détérioration fonctionnelle et minimiser aussi les risques professionnels, familial et social et économique que le patient peut avoir. On hospitalise en général un patient en accès maniaque.

Il tient difficilement à domicile. En général, on les hospitalise parce qu'ils sont dans l'agitation, l'irrétabilité, l'hétéro-agressivité ou bien l'auto-agressivité. Donc, quand il y a un manque de soutien de la famille, un jugement signifiant, persécuté, on me veut du mal, je connais le persécuteur, je veux le tuer.

Et quand il y a des complications associées et bien sûr, quand il n'y a pas de réponse à un traitement à domicile. En pratique, quand vous êtes dans un état de manie ou état mixte sévère ou résistant, déjà, devant l'épisode aigu, quand vous êtes devant un épisode, un patient qui a un trouble bipolaire en accès maniaque, on traite par les médicaments régulateurs, que ce soit en accès maniaque ou en accès dépressif. Vous traitez par les médicaments régulateurs, soit le valproate, soit le lithium, et en deuxième lieu, la carbamazépine.

S'il se présente en accès maniaque, sévère, résistant, vous ajoutez un neuroleptique au médicament régulateur. En général, c'est ce qu'on fait. Le médicament régulateur ne suffit pas seul.

On ajoute automatiquement, vous allez trouver les ordonnances des troubles bipolaires, toujours il y a un neuroleptique. Et il y a des neuroleptiques actuellement, récents, qui ont deux effets. Effet médicament régulateur et effet neuroleptique.

Si vous êtes devant une dépression sévère ou résistante, vous avez mis un tumeur régulateur, vous ajoutez un antidépresseur, ou bien vous ajoutez un tumeur régulateur, ou bien vous ajoutez de la motrigine, ou bien vous mettez des électrochocs. Vous voyez, quand vous êtes devant un état dépressif, on ne met jamais l'antidépresseur en premier. Quand vous êtes devant un patient bipolaire qui vient vous voir pendant la phase dépressive, vous traitez par le tumeur régulateur.

Et vous ajoutez un antidépresseur si ça ne marche pas. Après, quand il y a amélioration de l'état, vous diminuez progressivement le traitement que vous avez ajouté en deuxième lieu. Devant un patient bipolaire, on commence le traitement par le tumeur régulateur.

Si c'est sévère, résistant, c'est en général le cas, on ajoute un neuroleptique. Si c'est une dépression qui n'a pas répondu au tumeur régulateur, on peut ajouter un antidépresseur parce que là, on est couvert par le tumeur régulateur pour le virage maniaque. Mais il est mieux, il y a des médecins qui préfèrent ajouter notre tumeur régulateur, de la motrigine, de l'ECT avant de passer aux antidépresseurs.

Ça, c'est un schéma classique, très simple. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans la réalité. La prise en charge des épisodes aiguës maniaques, quand vous êtes devant un épisode maniaque ou bien hypomaniaque, si c'est un patient bipolaire, un patient qui prend déjà le traitement, vous voyez d'abord s'il prend bien son traitement.

S'il prend bien son traitement, vous ajoutez un autre traitement ou bien vous changez le traitement. S'il ne prend pas bien son traitement, vous augmentez la dose avant de changer. Et s'il n'est pas efficace, vous changez ou bien vous faites des associations.

Pour les traitements qu'on met en premier comme traitement curatif et qu'on peut mettre aussi comme traitement préventif, il y a le lithium, les antiépileptiques et il y a des neuroleptiques atypiques, à vie. Le lithium, le traitement préventif à vie, comme je vous ai dit ici, quand vous allez arrêter le traitement que vous avez ajouté en deuxième, ça veut dire que le patient va rester sous tumeur régulateur, à vie. Le tumeur régulateur peut être aussi un neuroleptique qui ont cette caractéristique d'être aussi tumeur régulateur.

Alors le lithium, l'avantage, il prévient les récides maniaques plus que dépressives. Et il prévient aussi le suicide, l'inconvénient, il y a des effets secondaires gênants et il faut faire des dosages sériques régulièrement. Il faut faire un bilan pré-lithium qui peut coûter cher.

Je ne vais pas vous donner les détails parce que vous allez voir ça dans le tumeur régulateur, dans le cours de la pharmaco. Les normes antimic-antiépileptiques, le valproate moins efficace que le lithium dans la manie, donc c'est quelqu'un qui fait plus de manie dans le lithium, c'est quelqu'un qui fait plus de dépression et plus de cycles rapides, on donne du valproate. D'accord ? C'est en fonction des cas.

La carbamazépine aussi plus efficace chez les cycles rapides, donc c'est quelqu'un qui fait des

cycles rapides plus de 4 épisodes maniaques par an, on va donner soit du tégrétole, soit de la carbamazépine, je ne dis pas le nom commercial, soit du valproate. Si il ne fait pas des cycles rapides, on peut donner du lithium. La motrigine, son avantage, c'est qu'elle est efficace sur les rechutes dépressives plus que maniaques.

Donc voilà quelque chose qui est efficace pour les rechutes dépressives. Il y a des patients bipolaires qui vont faire beaucoup plus de rechutes dépressives que maniaques. Dans ce cas, on donne du lithium.

L'inconvénient, c'est les problèmes cutanés. Voilà les médicaments, les différents neuroleptiques atypiques, antipsychotiques atypiques, le lonzapine, la resperidone, la repiprazole, la quetiapine et la mesfipride. Le lonzapine, on peut l'utiliser comme tumeur régulateur.

Il y a l'AMM comme tumeur régulateur. Alors, devant un patient qui a un épisode maniaque, on pratique, on hospitalise le patient le plus souvent. Donc en première intention, normalement, il faut donner un traitement tumeur régulateur comme on a dit, en monothérapie.

C'est rarement suffisant. On ajoute, donc en premier, on donne soit le lithium, soit le valproate. En deuxième intention, si on ne peut pas, on donne la carbamazépine.

C'est rarement insuffisant. Donc, des fois, on peut, si on n'a pas de tumeur régulateur, donner les neuroleptiques atypiques en première intention, surtout s'ils ont aussi un grand tumeur régulateur. On peut donner le lonzapine, la resperidone, voilà les doses avec lesquelles on peut commencer, la repiprazole, la quetiapine, la mesfipride.

Soit on va donner un neuroleptique classique. Ça, hors AMM. Les classiques, ils sont utilisés hors AMM.

Les classiques, c'est quels médicaments ? C'est l'aldol, l'argaxyl, l'ozyno. Et vous allez voir, dans nos ordonnances, il y a beaucoup d'ordonnances aldol, l'argaxyl, l'ozyno. Les malades n'ont pas les moyens d'acheter les atypiques.

Les atypiques, ça coûte trop cher. Ça peut aller jusqu'à 2000 dirhams par mois, le traitement. Alors que les atypiques, c'est 1 dirham.

C'est vrai que ça finit vite, mais c'est 20 dirhams le flacon, ça finit vite, mais ça n'arrive pas jusqu'à 1000 dirhams par mois. Donc souvent, on utilise des associations. Les associations de première intention, lithium ou valproate associé au neuroleptique atypique.

Deuxième intention, lithium avec valproate. Alors les détails, c'est pour les spécialistes. Vous, pour savoir, c'est compliqué.

Troisième intention, lithium ou valproate, les classiques. Carbamazépine, qui est en deuxième intention comme tumeur régulateur avec les classiques et ainsi de suite. Là, c'est les dernières

guidelines de 2018.

Vous voyez, là, pendant la phase maniaque aiguë, on commence par le lithium. Ça, c'est les médicaments qu'on donne en monothérapie. Traitement, prévention de l'épisode chimique.

Voilà les traitements qu'on donne. Là, c'est les traitements d'association qu'on donne. Là, c'est les nouveaux traitements.

Ça, c'est les guidelines pour la phase aiguë. Là, c'est pour l'entretien. Là, c'est pour la phase aiguë.

Et même pour la phase de dépression, la prévention de la dépression. Alors, traitement de la dépression bipolaire. L'essentiel, quand vous êtes devant un patient qui est en axe maniaque, vous commencez par le tumeur régulateur.

Vous associez, et ça, en la majorité des cas, un neuroleptique. Sinon, vous allez commencer par des associations. Changez les associations si ça ne marche pas.

Si vous êtes devant un patient qui a un épisode dépressif, déjà, il est sous traitement. Vérifiez aussi la dose du traitement. S'il est efficace.

S'il n'est pas efficace, vous augmentez la dose. Quand je parle du traitement, c'est un tumeur régulateur. Si nécessaire, ajoutez un antidépresseur qui est prescrit hors AMM.

Si un patient a un épisode dépressif ou un patient bipolaire, c'est hors AMM que vous donnez les antidépresseurs. Mais vous les donnez toujours en association, au moins, si c'est hors AMM. Hors AMM, ça veut dire hors la loi.

Si c'est hors AMM, ça veut dire que vous les donnez au moins associés à un tumeur régulateur. Ici, en cas de patient traité, quand je parle traité, ça veut dire qu'il est traité par un tumeur régulateur ou bien par un neuroleptique. Vous augmentez la dose du tumeur régulateur pour traiter sa dépression.

Si ça ne marche pas, à ce moment-là, vous ajoutez l'antidépresseur. Mais avec le tumeur régulateur toujours. Les conseillers de prescrire les IRSS sont couverts d'un tumeur régulateur.

Toujours, j'insiste. Toujours en association avec le tumeur régulateur, j'insiste. On peut utiliser les inhibiteurs de la capture de la sérotonine et de la noradrénaline.

Là, il y a la néptyline, la myosirine, la mirtazapine qui peuvent être aussi utilisées. Les tricycliques ne sont pas recommandés en première intention. Il y a des patients chez qui vous allez utiliser tous les antidépresseurs et il ne vous reste que les tricycliques.

C'est en dernière intention. Mais toujours avec le tumeur régulateur. Alors prise en charge des épisodes dépressifs aigus toujours.

Débutez l'antidépresseur. Et quand vous introduisez l'antidépresseur, vous l'introduisez à des posologies moins basses que dans la dépression. Par exemple, vous allez mettre la moitié de la dose.

Et si ça ne marche pas, vous pouvez augmenter. Mais vous ne dépassez pas la dose que vous donnez à un patient qui a juste une dépression. Et si nécessaire, on peut ajouter des benzodiazépines pour le sommeil, des hypnotiques pour le sommeil ou bien des benzodiazépines pour l'anxiété.

Et bien sûr, la durée aussi. La durée est moindre. Dès qu'il y a devant un patient dépressif suivi pour un trouble bipolaire, dès qu'il y a amélioration de la dépression, vous arrêtez l'antidépresseur.

Vous n'attendez pas neuf mois. Dès qu'il y a amélioration, vous arrêtez l'antidépresseur. Alors là, quelque chose que je vais demander de retenir pour faire la différence.

Quand vous êtes devant un patient qui a une dépression, dans le cadre d'un trouble bipolaire type 1, ça veut dire le patient, il fait des accès maniaques et il est venu vous voir en phase dépressive. Là, vous prescrivez, comme on a dit, le tumeur régulateur en premier et après vous pouvez associer un antidépresseur si ça ne marche pas. En deuxième intention, vous pouvez commencer par un neuroleptique et après associer un antidépresseur.

Mais quand vous êtes devant un patient qui a une dépression dans le cadre d'un trouble bipolaire type 2, ça veut dire quoi? Le patient, il fait des hypomanies. Il ne fait pas de manie. Il fait des hypomanies.

Qu'est-ce que vous allez donner comme traitement? En première intention, vous n'allez pas donner un antidépresseur. Vous allez donner la quetiapine. La quetiapine, dans les dernières guidelines, traite la dépression bipolaire type 2. D'accord? Donc, vous donnez la quetiapine.

Ici aussi, vous pouvez donner. Si ça n'améliore pas avec le lithium, avec la mirtazapine, on peut se donner. Mais ici, c'est systématique.

Il n'y a pas autre chose ici. Je ne vous ai pas mis autre chose. Et on a même la dose efficace pour la dépression.

C'est 300 mg par jour le soir. D'accord? En deuxième intention, on peut mettre du lithium, de la mirtazapine, du valproate, du lithium au RSS. Là, on introduit les antidépresseurs.

D'accord? Mais ça, je vais vous demander de le retenir. À la différence de ça. Vous voyez la différence? Dépression bipolaire 1, dépression bipolaire 2. Il y a une grande différence.

Là, c'est des anciennes. Vous pouvez l'enlever, parce que je vous ai mis les récentes. Ça, c'est

les récentes 2018.

Et ça, c'est les anciennes 2009. Mais aussi, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. Comment arrêter l'antidépresseur? S'il y a une rémission ou une baisse totale de sévérité des symptômes, depuis au moins 8 semaines, on arrête l'antidépresseur.

L'épisode dépressif justifie une durée de traitement de consolidation plus courte que la dépression bipolaire, l'arrêt progressif plusieurs semaines, surtout pour la vaccine et la paroxétine. L'arrêt, on le fait progressivement pour qu'on ne tombe pas dans la rechute. Les dépressions bipolaires sont difficiles à traiter.

Alors, information des patients traités par les antidépresseurs, la possibilité de survenue de livrages. Ça, je n'arrête pas d'insister. La nécessité de respecter les prescriptions.

Il ne doit pas augmenter les doses de l'antidépresseur parce qu'ils ont cette nostalgie de l'épisode maniaque. Il voudra rapidement retourner à l'épisode maniaque ou bien l'épisode hypomaniaque. Si vous donnez l'antidépresseur, la dose pourra avoir l'effet inverse.

Surveiller rapidement au cas d'apparition ou d'aggravation des suicidaires, d'angoisse, agitation, signe d'acathisie qui peuvent orienter le virage maniaque. L'acathisie, c'est des gens qui ne tiennent pas en place, qui n'arrêtent pas de bouger. Le traitement préventif, on prévient.

Par exemple, vous l'avez mis sous tumour régulateur, ça n'a pas marché, c'est en général le cas. Vous le mettez sous neuroleptique associé. Après, quand il va se stabiliser, vous arrêtez le neuroleptique, vous le laissez sous tumour régulateur.

Le tumour régulateur, c'est le traitement d'entretien qui va prendre à vie. Première intention, on met le lithium. Sinon, on met les valproates ou bien les neuroleptiques qui ont là et même comme tumour régulateur le lonzapine, la quetiapine, la ripiprasole.

En deuxième intention, c'est les carbamazépines. Après, les associations. En deuxième intention, il y a des patients qui ne vont pas se stabiliser sous un seul traitement.

Donc, on peut regarder le tumour régulateur avec le neuroleptique à vie. À vie, parce que les malades, ils viennent vous demander est-ce qu'il est temps d'arrêter le traitement. Est-ce qu'il est stabilisé pendant quatre ans, est-ce que je dois arrêter le traitement ? Non.

Non. Quatre ans, justement. C'est parce que vous êtes sous traitement.

Comme si un diabétique vient vous dire je suis stabilisé sous le traitement, est-ce que pendant deux ans est-ce que j'arrête le traitement ? Non. Vous n'arrêtez pas. Alors, les principes respecter l'indication, la coopération du patient, surveillance clinique, tous les médicaments qu'on va donner nécessitent l'iono, NFS régulièrement et le dosage.

Ça, vous allez le voir en pharmacie. Je ne vais pas insister. La durée à vie au minimum cinq ans, ça, on le dit juste pour un petit peu calmer le malade et juste dans des cas particuliers, c'est les cas des accès psychotiques aigus, post-toxiques ou bien suite à un événement stressant d'allure maniaque.

Des accès aigus d'allure maniaque, on peut aller jusqu'à cinq ans. Alors ça, c'est le traitement d'entretien, donc de prévention. Là, l'uthiome, c'est ce qu'on a dit.

C'est les dernières guidelines de 2018. Là, il faut traiter les précipitants, donc les facteurs déclenchants, traiter la phase maniaque. La phase inter-accès, elle doit être aussi stabilisée.

La phase dépressive à traiter, et puis traiter aussi les rechutes. C'est le traitement préventif. Alors la psychoéducation, c'est capital.

C'est des conseils que vous allez donner aux patients pour les stigmatiser, parce que les gens peuvent vivre normalement. Ce n'est pas comme les autres pathologies chroniques de mauvais pronostic. Il faut savoir que ça donne des rechutes.

C'est une maladie à rechutes. Donc les patients doivent être bien sensibilisés, et puis chercher les facteurs de risque et les facteurs qui déclenchent la maladie pour essayer de les prévenir. L'entourage joue un rôle capital parce qu'il va détecter les premiers symptômes.

Un patient ne va pas voir qu'il a commencé à dépenser beaucoup d'argent, ne va pas voir qu'il a commencé à moins bien dormir, ou bien qu'il est devenu hyperactif. C'est la famille qui va détecter ses premiers symptômes. Alors aider, demander à la famille de garder ses activités, aïer les activités avec le proche, avec le malade, pour détecter ses pensées.

Il peut avoir des projets multiples. Lui, il est en train de préparer. Il peut même passer à l'action et la famille n'est pas au courant.

Mais s'il reste en contact avec la famille, il peut détecter les projets multiples des patients. Et bien sûr, savoir réagir devant les prodromes. Donner les soins qu'il faut, protection financière, clé de la voiture.

Donc, quand le patient est en accès, lui prendre les clés de la voiture. Lui prendre sa carte bleue. Bien sûr, il lui le rendra après, pas définitivement.

Lui prendre son chéquier. Et puis garder le temps. Quand le patient devient délirant, hyperactif, hypersymptôme, hyperexcité, il faut gagner du temps, le temps de l'amener à l'hôpital.

Donc, bien sûr, les moyens de protection financière et de sécurité du patient sont très importants. Devant le prodrome, bien sûr, c'est des patients logorhées qui ne vont pas arrêter de parler. Donc, des conversations brèves et limiter les stimulus.

Ils sont stimulés rapidement par n'importe quoi. Les bruits, la musique, les lumières. Il faut arrêter les stimulus.

Ne pas tenter de raisonner, c'est un délirant. Les mégalomaniques le plus fort essaient de gagner du temps. Alors, rester ferme avec lui, bien sûr, ne pas faire de chantage avec le patient.

Gagner surtout du temps et assurer sa sécurité en prenant sa carte bleue, son chéquier et ses clés de la voiture. Alors, les périodes intercritiques, comme on a dit, elles peuvent aussi être symptomatiques. Donc, il faut aussi s'intéresser à ces périodes-là et il faut aussi les traiter.

C'est l'objectif du traitement préventif. Les conséquences, il peut y avoir des conséquences pendant la phase critique, pendant la phase intercritique, c'est l'intérêt de la psychoéducation et l'intérêt de garder le traitement à vie. Donc, ce sont des maladies à rechute avec des conséquences graves qui peuvent engendrer le pronostic vital du patient dans le cadre du suicide ou bien des conduites à risque, de l'entourage dans le cadre du suicide altruiste ou bien des homicides délirants, des conséquences financières professionnelles.

Et je vous remercie. Voilà des gens qui ont des troubles du polaire que vous connaissez. Des écrivains, des artistes, des peintres, des hommes politiques, des acteurs de cinéma.

Vous m'avez pas envoyé le mail du responsable.